

Preguntas para el levantamiento de información

Aplicativo de costeo de procedimientos quirúrgicos por tiempo (metodología TDABC)

Visita institucional al hospital | 22 de julio de 2026

Bloque 1. Captura del dato en el procedimiento quirúrgico

El costeo TDABC se construye sobre los minutos reales de cada procedimiento.

- 1 Hoy, cuando se realiza una cirugía, ¿quién registra los tiempos y en qué momento lo hace? (instrumentadora, circulante, anestesia, secretaría de quirófano)
- 2 ¿Qué marcas de tiempo registran exactamente: entrada del paciente a sala, inicio de anestesia, incisión, cierre, salida de sala, ingreso a recuperación? ¿Cuáles son obligatorias y cuáles se diligencian después?
- 3 ¿El registro se hace en papel o directamente en un sistema? Si es en papel, ¿en qué momento y quién lo digita?
- 4 ¿Existe un reloj o pantalla de referencia dentro de la sala? ¿Los relojes de los distintos servicios están sincronizados?
- 5 Cuando una cirugía se complica o se convierte (por ejemplo, de laparoscópica a abierta), ¿cómo queda registrado ese cambio?
- 6 ¿Cómo se registran los tiempos no quirúrgicos: alistamiento y aseo de sala entre cirugías, esperas por el paciente, cancelaciones de última hora? ¿Alguien los mide hoy?
- 7 ¿Cuánto tiempo adicional por cirugía estaría dispuesto a invertir el personal de sala para registrar información en la aplicación?
- 8 ¿Se cuenta con conectividad estable y algún dispositivo dentro de la sala (tablet, computador, lector de código de barras), o el registro tendría que hacerse fuera de sala?

Bloque 2. Insumos, medicamentos y dispositivos

- 9 ¿Cómo se despachan los insumos a quirófano: kit o paquete quirúrgico predefinido, pedido por cirugía, o carro de sala?
- 10 ¿Cómo se registra el consumo real frente a lo devuelto? ¿Lo no utilizado regresa a farmacia y queda soporte de esa devolución?
- 11 ¿Los insumos cuentan con código de barras y hay lectores disponibles? ¿Manejan código ATC en medicamentos, código CUM o codificación propia?
- 12 ¿Qué valor se toma como costo unitario del insumo: precio de compra, promedio ponderado o tarifa de venta? ¿Con qué periodicidad se actualiza?
- 13 ¿Cómo se manejan los implantes y el material de osteosíntesis en consignación, así como los equipos aportados por el proveedor? ¿Se incorporan al costo del procedimiento?
- 14 ¿Cómo se registran el desperdicio, el insumo abierto y no utilizado, y las devoluciones por vencimiento?

Bloque 3. Talento humano y costo por minuto

- 15 ¿Bajo qué modalidad está vinculado el personal quirúrgico: planta, prestación de servicios, agremiación u honorarios por procedimiento?
- 16 ¿El cirujano se remunera por procedimiento (tarifa fija) o por tiempo? ¿Cuál es el esquema para anestesiología?
- 17 ¿Cuántos minutos disponibles reales estiman por profesional al mes, descontando vacaciones, incapacidades, reuniones y capacitación?
- 18 ¿La información de costo laboral puede entregarse por cargo o rol promedio, o únicamente de forma agregada? ¿Existe alguna restricción por protección de datos o acuerdo sindical?
- 19 ¿Quién dentro del hospital tendría la autoridad para cargar y aprobar los costos por minuto de cada rol?

Bloque 4. Salas, equipos y costos indirectos

- 20 ¿Cómo se calcula hoy el costo por hora de quirófano? ¿Ese indicador ya existe o habría que construirlo?
- 21 ¿Cuál es la tasa real de utilización de las salas: horas programadas frente a horas efectivamente operadas al mes?
- 22 ¿Cómo se distribuyen actualmente los costos indirectos (administración, servicios públicos, esterilización, lavandería, mantenimiento, depreciación)? ¿Por número de cirugías, por metros cuadrados, por horas de uso?
- 23 ¿La central de esterilización factura o imputa costos a quirófano? ¿Cómo se costea un paquete estéril?
- 24 ¿Existe inventario de equipos médicos con valor de compra, vida útil y contrato de mantenimiento asociado?

Bloque 5. Sistemas de información e integración

Preguntas dirigidas principalmente al equipo de tecnología del hospital.

- 25 ¿Qué sistema de información hospitalario (HIS) y qué ERP utilizan? ¿Qué versión y qué proveedor?
- 26 ¿El sistema expone API, permite consulta directa a base de datos, o únicamente genera reportes en Excel o PDF? ¿El proveedor autoriza ese acceso?
- 27 ¿En qué sistema reside hoy cada dato: agenda quirúrgica, historia clínica, farmacia e inventario, nómina y facturación? ¿Es un solo sistema o son módulos independientes?
- 28 ¿Cuál es el identificador único de una cirugía en su sistema? ¿Es posible enlazar nuestros registros con ese identificador?
- 29 ¿Prefieren que la aplicación importe archivos planos de forma periódica o que se integre en línea con sus sistemas?

- 30 En cuanto a infraestructura, ¿aceptan despliegue en la nube o exigen servidor local? ¿Qué exige su política de seguridad de la información?
- 31 ¿Cómo gestionan hoy la autenticación de usuarios? ¿Cuentan con directorio activo o inicio de sesión único (SSO) al que debamos integrarnos?
- 32 ¿Qué exige su política de historia clínica y el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012? ¿Podemos almacenar la identificación del paciente o debe anonimizarse?

Bloque 6. Protocolos y estandarización clínica

- 33 ¿Cuentan con protocolos escritos por procedimiento (guía de manejo, kit estándar, tiempo estimado)? ¿Sería posible revisar dos o tres como ejemplo?
- 34 ¿Con qué codificación identifican los procedimientos: CUPS, código interno o denominación libre del cirujano?
- 35 ¿Qué nivel de variación consideran normal entre dos cirujanos que realizan el mismo procedimiento?
- 36 ¿Existe un mapa de proceso del paciente quirúrgico, desde la consulta y programación hasta recuperación y alta?
- 37 ¿Qué procedimiento trazador recomiendan para una prueba piloto, idealmente de alto volumen y baja complejidad?

Bloque 7. Decisión, valor y gobierno del sistema

Preguntas dirigidas principalmente al nivel directivo.

- 38 ¿Qué decisión concreta tomarían si contaran con el costo real por procedimiento? (negociación de tarifas, continuidad de un servicio, cambio de proveedor, ajustes contractuales con las EPS)
- 39 ¿Hoy pueden establecer si obtienen margen o pérdida en cada contrato con las aseguradoras? ¿Cómo lo estiman?
- 40 ¿Qué indicadores revisa el comité directivo cada mes? ¿La aplicación podría alimentarlos?
- 41 Cuando el sistema evidencie que un procedimiento cuesta más de lo que se factura, ¿quién debe ser notificado y en qué plazo?
- 42 ¿Qué áreas o actores podrían presentar resistencia a la implementación del sistema y por qué razones?
- 43 ¿Se han adelantado antes iniciativas de costeo en el hospital? ¿Cuáles fueron sus resultados y sus limitaciones?
- 44 ¿Qué dependencia sería la responsable del sistema: financiera, calidad, quirófano o planeación?
- 45 ¿Existen requerimientos de reporte externo que el sistema deba apoyar (SIHO, RIPS - Resolución 3374, habilitación, acreditación)?

Bloque 8. Prueba piloto y siguientes pasos

- 46 Si se iniciara un piloto, ¿en qué servicio, con cuántas salas y durante qué periodo lo desarrollaríamos?
- 47 ¿Quién sería la contraparte técnica del hospital y qué disponibilidad semanal podría destinar?
- 48 ¿Qué resultado concreto tendría que evidenciar la aplicación para que ustedes la consideren útil?
- 49 ¿Sería posible acompañar y observar una jornada quirúrgica completa, sin intervenir en el proceso, para documentar el flujo real de información?
- 50 ¿Cuáles son los plazos e instancias internas de aprobación en caso de que decidan avanzar con la implementación?